

Enfermedad del Disco Intervertebral (IVDD)

¿Qué es la IVDD?

La columna es una pila de huesos (vértebras) con almohadillas (discos) entre ellos. Un disco sano es como una dona de gelatina: una capa exterior dura con un centro blando. Con la edad, el centro se endurece (como pasta de dientes seca) y la capa exterior se debilita. Cuando el disco se **hernia**, su material empuja hacia el canal espinal. Esto puede ocurrir con cualquier actividad, desde un estornudo hasta un salto.

Un disco herniado puede dañar la médula espinal al **comprimirla** (como pisar una manguera), **golpearla** y causar **inflamación**.

Signos y etapas

Un disco en el **cuello** puede afectar las cuatro patas; uno en la **espalda** afecta las patas traseras.

Etapas	Lo que usted ve
1 — Solo dolor	Come menos, se esconde, llora al cargarlo, evita escaleras o saltos
2 — Tambaleo	Camina pero como "borracho", arrastra o cruza las patas
3 — No camina	Mueve las patas pero no camina sin ayuda; suele controlar la vejiga
4 — Parálisis	No mueve las patas pero siente los dedos ; necesita ayuda para orinar
5 — Sin dolor profundo	No mueve ni siente los dedos — lo más grave

Diagnóstico

La **resonancia magnética (RM)** muestra mejor la columna y la médula espinal y es necesaria para planear la cirugía. Las radiografías solo muestran hueso; la tomografía (TAC) es rápida pero no muestra el estado de la médula.

Tratamiento médico (sin cirugía)

1. Reposo estricto por 4–6 semanas — lo más importante:

- Jaula o área pequeña; nada de correr, saltar ni escaleras
- Carguelo afuera solo para ir al baño, con paseos muy cortos
- Continúe hasta que no haya dolor ni debilidad; luego regrese a la actividad poco a poco

2. Control del dolor por 1–2 semanas: antiinflamatorios, analgésicos (gabapentina, tramadol), relajantes musculares.

Funciona en más de la mitad de los casos, pero **el problema a menudo regresa** y suele ser peor. **No use quiropráctico.** Evite saltos y juegos bruscos de por vida.

¿Cuándo se recomienda cirugía?

- Episodios repetidos de dolor o debilidad
- No mejora con reposo y medicamentos
- No puede caminar
- Compresión importante de la médula en la RM

Cirugía y recuperación

El cirujano retira el material del disco que presiona la médula.

- Hospitalización de 1–3 días
- Retiro de puntos y revisión a las **2 semanas**
- Regreso gradual a la actividad normal después de unas **6 semanas**

Resultados

- Si su mascota todavía **siente los dedos**, la cirugía tiene un éxito de alrededor del **90%**
- Solo el 10–25% tiene recaídas después de la cirugía, mucho menos que con reposo solo
- Si **perdió el dolor profundo** (etapa 5), el éxito baja y cerca del **10%** desarrolla **mielomalacia**, un daño progresivo y mortal de la médula, generalmente en 3–14 días (cerca del 30% en Bulldogs Franceses)

Llámenos de inmediato si su mascota deja de caminar, pierde sensibilidad, no puede orinar o el dolor empeora.